

# **Avaliação psicossocial da dor crônica:** compreendendo fatores emocionais, cognitivos e sociais



# Compreendendo fatores emocionais, cognitivos e sociais

Você já atendeu uma pessoa com dor persistente, fez todos os exames necessários, seguiu os protocolos clínicos, mas ainda assim ficou com a sensação de que algo estava faltando? Isso ocorre pois a dor crônica quase nunca se explica apenas por lesões ou alterações físicas. Ela é moldada por uma complexa rede de fatores emocionais, cognitivos e sociais — e é exatamente sobre isso que vamos conversar.

**Vamos embarcar juntos em uma jornada para entender a dor crônica de uma maneira mais completa e humana. Nesta apresentação, vamos explorar como os fatores emocionais, cognitivos e sociais influenciam a dor que muitas pessoas sentem diariamente.**

Também vamos aprender a combinar dados clínicos, narrativos e escalas para obter uma visão mais completa da dor do paciente. Para finalizar, veremos como aplicar o gráfico de radar na prática clínica, tornando nossa abordagem ainda mais eficaz e integrada.

**Pronto(a) para começar? Vamos lá!**



# Compreendendo fatores emocionais, cognitivos e sociais

## **Objetivos**

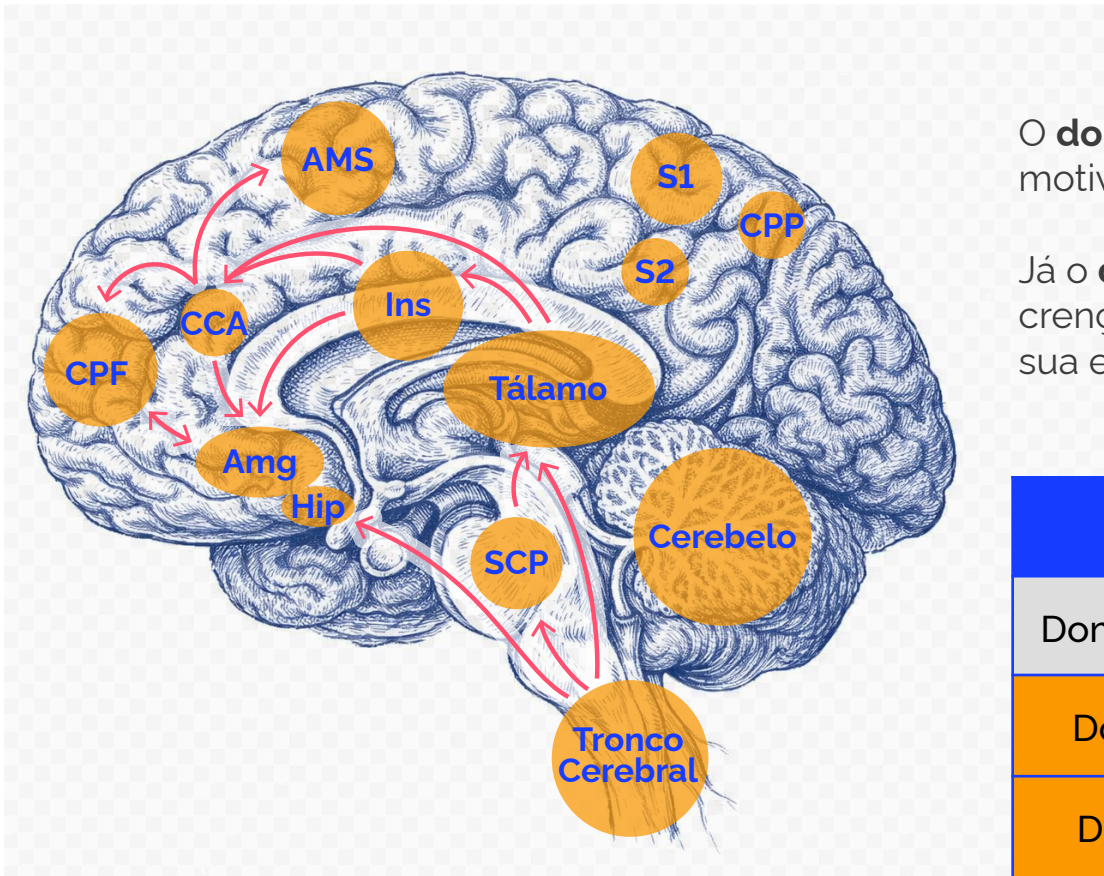
Compreender como fatores emocionais, cognitivos e sociais influenciam a dor crônica, reconhecer a importância na avaliação clínica e identificar ferramentas úteis para esse processo.

## **Conteúdo**

- Dimensões afetiva, cognitiva e socioambiental da dor.
- Influência de estresse, crenças e suporte social.
- Principais ferramentas: PHQ-9, PCS, TSK, FABQ, IEQ e SRI.
- Triangulação de dados clínicos, narrativos e escalas.
- Aplicação do gráfico de radar na prática clínica.



# Avaliação multidimensional da dor na prática



O **domínio afetivo-motivacional** da dor se refere aos aspectos emocionais e motivacionais que acompanham e influenciam a dor.

Já o **domínio cognitivo-avaliativo** da dor refere-se aos processos mentais e crenças que moldam a forma como o indivíduo interpreta, compreende e reage à sua experiência de dor.

| Domínio                          | Pergunta que responde                  |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Domínio Sensorial-Discriminativo | O que sente, onde, quanto e como dói   |
| Domínio Afetivo-Motivacional     | Como a dor faz o(a) paciente se sentir |
| Domínio Cognitivo-Avaliativo     | O que ele/ela pensa sobre essa dor     |



# A multidimensionalidade da dor e o papel dos fatores psicossociais

A dor não é apenas um sintoma físico – fatores emocionais, cognitivos e sociais influenciam a intensidade e o impacto.

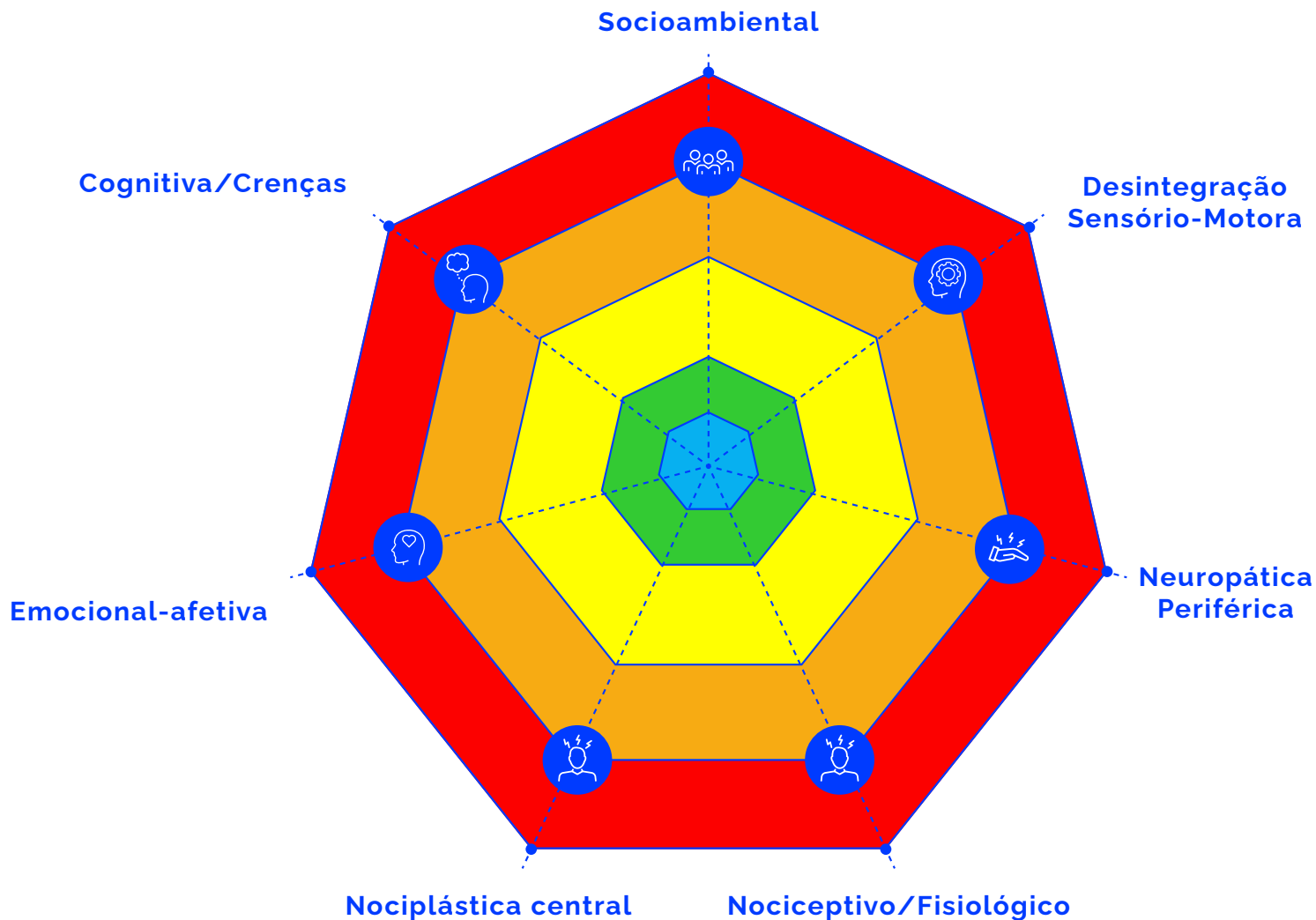
A compreensão desses fatores permite **intervenções mais eficazes** e evita tratamentos exclusivamente farmacológicos que podem ser ineficientes.





# Gráfico de radar

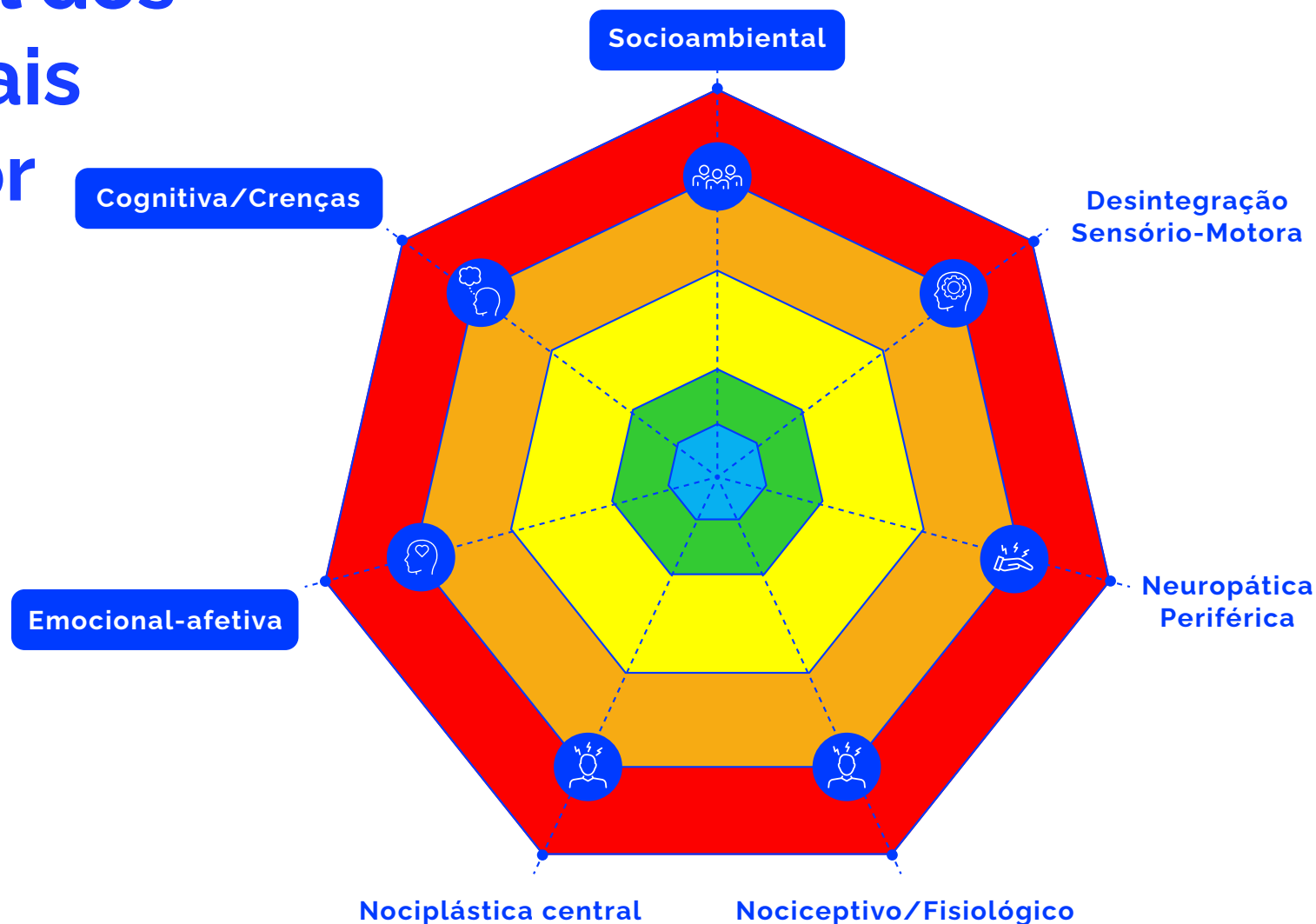
Exemplo de um gráfico de radar com 7 domínios distintos (mas potencialmente sobrepostos) da experiência da dor que pode ser útil para avaliação clínica e decisões de tratamento para pessoas com dor.





# Integrando o papel dos fatores psicossociais na avaliação de dor

O gráfico de radar permite visualizar o **impacto de diferentes fatores na dor crônica** e aguda e orientar o tratamento.





# Fatores emocionais/afetivos

## Como as emoções influenciam a dor?

O **sofrimento emocional** pode amplificar a percepção da dor.

A dor crônica e a **depressão** criam um **ciclo vicioso** de piora progressiva.

O **estresse e a ansiedade** aumentam a **hiperexcitabilidade do sistema nervoso**, intensificando a dor.

## Como avaliar?

**Histórico do paciente:** há relação entre dor e estresse/ansiedade?

**Narrativa:** o paciente relata sintomas emocionais associados à dor?

**Ferramentas de avaliação:** PHQ-9 (depressão), HADS (ansiedade e depressão).

**Nunca deixe de discutir com a equipe o encaminhamento para um profissional competente em saúde mental.**





# Fatores cognitivos e crenças

## Como crenças e padrões de pensamento afetam a dor?

**Catastrofização da dor:** pensamentos negativos exagerados aumentam a percepção do sofrimento.

**Medo da dor relacionada ao movimento (cinesiofobia):** o paciente evita atividades por acreditar que a dor indica dano estrutural.

**Baixa autoeficácia:** a falta de confiança em lidar com a dor leva ao isolamento e à piora funcional.

## Como avaliar?

**Histórico do paciente:** ele acredita que precisa estar sem dor para retomar atividades?

**Narrativa:** expressões como "não há solução", "a dor vai piorar", "vou acabar incapacitado".

**Ferramentas de avaliação:** PCS (catastrofização), TSK (medo do movimento), FABQ (crenças sobre atividade física).



# Fatores socioambientais

## Como o ambiente e a rede de apoio influenciam a dor?

**Falta de suporte social:** pacientes sem apoio familiar ou social podem ter pior controle da dor.

**Fatores socioeconômicos:** baixa renda, desemprego e baixa escolaridade impactam no acesso ao tratamento.

**Ambiente de trabalho:** condições estressantes podem perpetuar a dor.

## Como avaliar?

**Histórico do paciente:** existe suporte familiar e social adequado?

**Narrativa:** relatos como "ninguém acredita na minha dor", "não posso perder o emprego".

**Ferramentas de avaliação:** IEQ (injustiça percebida), MOSS (suporte social).



# Triangulação de fatores psicossociais para avaliação clínica

A avaliação deve considerar múltiplas fontes de informação:

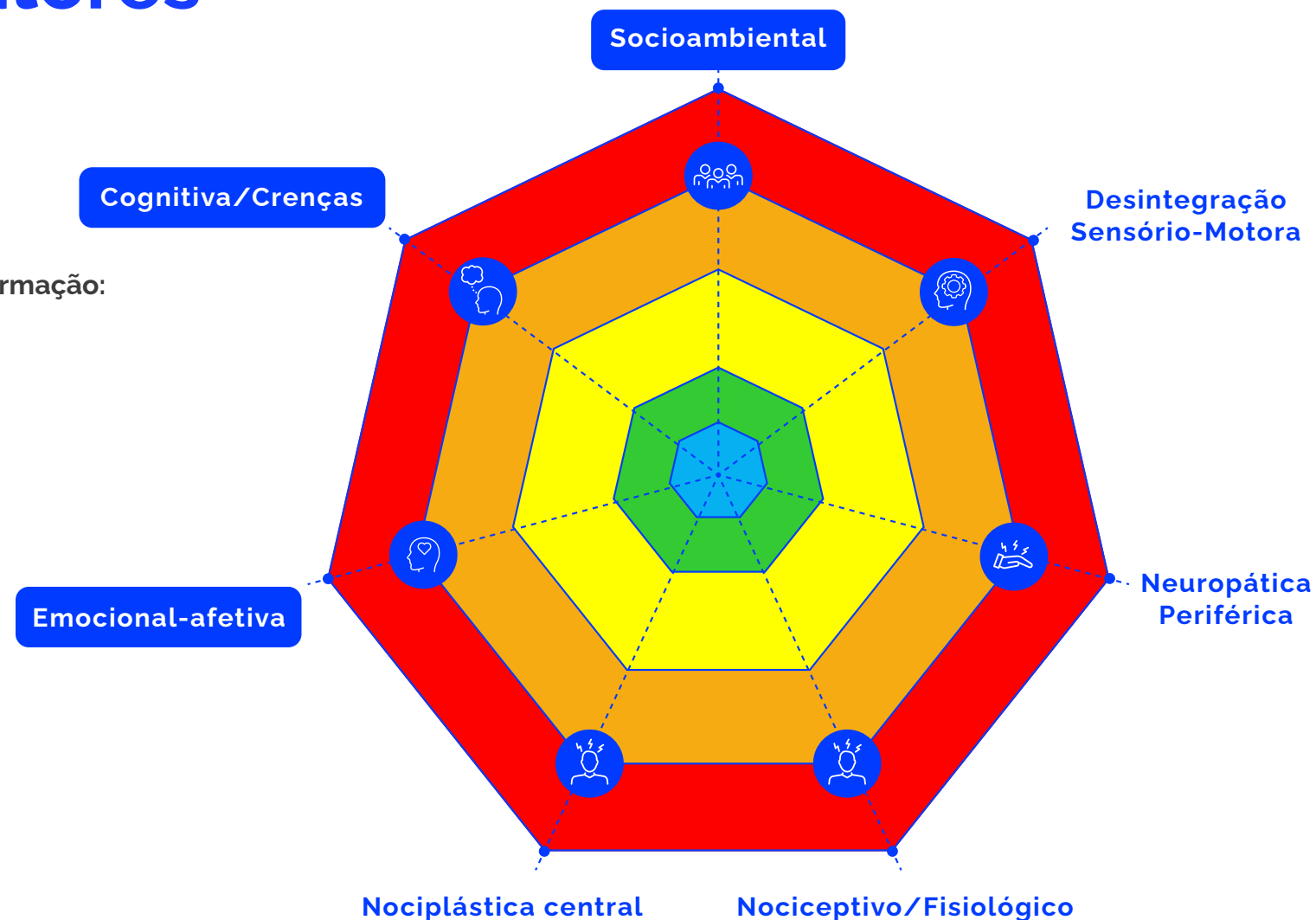
**Histórico do paciente** → quando a dor começou?  
Há relação com eventos emocionais ou sociais?

**Narrativa** → o paciente verbaliza sentimentos negativos ou crenças limitantes?

**Testes Padronizados** → aplicação de escalas para mensuração objetiva.

**Avaliação clínica** → sinais clínicos, comportamentos, testes de provocação ou alívio de sintoma.

**Outros** → resposta a fármacos, progressão ou flutuação do sintoma e respostas inconclusivas ou inesperadas.





## Exemplos de ferramentas ou sinais clínicos atualmente disponíveis para estimar a magnitude da disfunção/impacto em cada um dos 7 domínios descritos pelo gráfico de radar.

| Domínio de avaliação                      | Cognições ou crenças mal-adaptativas                                                                         | Contexto socioambiental                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Histórico da queixa                       | Sem padrão definido, pode ser aguda ou crônica, traumática ou não traumática                                 | Pode ser mais provável quando a patogênese ocorreu em um ambiente compensável ou ligada a outros estressores |
| Narrativa do paciente                     | Exemplos: crenças de que dor é igual a lesão ou que 100% de alívio é necessário antes de retomar a atividade | Sente-se sobre constante vigilância (ex. envolvimento médico legal)                                          |
| Avaliações padronizadas de autorrelato    | Ferramentas de diagnóstico de autorrelato (ex. PCS, TSK, FABQ)                                               | Ferramentas de diagnóstico de autorrelato (ex. MOSS, IEQ)                                                    |
| Avaliações clínicas padronizadas e sinais | Comportamentos exagerados ou inconsistentes da dor fora da proporção da magnitude dos testes                 | Sinais sugestivos de exagero intencional podem promover uma pista, mas a interpretação deve ser cuidadosa    |
| Outras observações                        | Preferência por métodos de enfrentamento passivos, como o pensamento "tudo ou nada"                          | Aconselhados a evitar atividades ou "esforços" até que um caso posterior seja resolvido                      |

Fonte: Adaptado de Walton e Elliott (2018).



# Reflexão final

Entender fatores psicossociais melhora a abordagem do tratamento.

O gráfico de radar auxilia na visualização e tomada de decisão terapêutica.

A dor crônica não pode ser tratada apenas com fármacos – um olhar ampliado é essencial!

## **Pergunta Reflexiva**

**"Como a sua prática clínica pode integrar a avaliação psicossocial no atendimento às pessoas com dor crônica?"**



## Referências

RIGANELLO, F.; SODDU, A.; TONIN, P. Addressing Pain for a Proper Rehabilitation Process in Patients With Severe Disorders of Consciousness. **Frontiers in Pharmacology**, [s. l.], v. 12, p. 628980, 17 fev. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fphar.2021.628980>. Acesso em: 24 mar.

WALTON, D. M.; ELLIOTT, J. M. A new clinical model for facilitating the development of pattern recognition skills in clinical pain assessment. **Musculoskeletal Science & Practice**, [s. l.], v. 36, p. 17-24, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.msksp.2018.03.006>. Acesso em: 24 mar. 2026.

WALTON, D. M.; MARSH, J. The Multidimensional Symptom Index: A new patient-reported outcome for pain phenotyping, prognosis and treatment decisions. **European Journal of Pain**, [s. l.], v. 22, n. 7, p. 1351-1361, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/ejp.1225>. Acesso em: 24 mar. 2026.



## Ficha técnica

### MINISTÉRIO DA SAÚDE

**Secretaria de Atenção Primária à Saúde - SAPS**  
**Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde - DEPPROS**  
**Núcleo Técnico de Gestão da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS - NTG PNPIC.**

**Angela Fernandes Leal da Silva** – Diretora do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde – DEPPROS.

**Paulo Roberto Sousa Rocha** – Coordenação Geral e Referência Técnica para a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS – NTG PNPIC/DEPPROS/SAPS/MS.

**Daniel Miele Amado** – Referência Técnica para a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS – NTG PNPIC/DEPPROS/SAPS/MS.

**Nathalia Oliveira da Silva** – Assessora Técnica no Núcleo Técnico de Gestão da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS – NTG PNPIC/DEPPROS/SAPS/MS.

### UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

**Reitoria**  
Ursula Rosa da Silva

**Vice-Reitoria**  
Eraldo dos Santos Pinheiro

**Coordenação Geral**  
Julieta Carriconde Fripp - Coordenadora da Cuidativa (Centro Regional de Referência em Cuidados Paliativos FAMED/UFPEL), Diretora da Faculdade de Medicina da UFPEL.

**Coordenadora Adjunta**  
Simone da Fonseca Sanghi - Assistente Social da Cuidativa (Centro Regional de Referência em Cuidados Paliativos FAMED/UFPEL), Colaboradora dos processos de Gestão na Cuidativa.



**UFPEL**





## Ficha técnica

### CRÉDITOS DO CURSO

#### Coordenação Geral

Paulo Roberto Sousa Rocha  
Julieta Carriconde Fripp  
Simone da Fonseca Sanghi

#### Apoio Administrativo / Secretaria

Luciano Avila dos Santos

#### Coordenação de Conteúdo

Amirah Adnan Salman  
Bárbara Cury Soubhia  
Manuela Samir Maciel Salman

#### Consultoria e Revisão de Conteúdos

Amirah Adnan Salman  
Andrea Cristina Lovato Ribeiro  
Bárbara Cury Soubhia  
Julieta Carriconde Fripp  
Manuela Samir Maciel Salman  
Nathalia Oliveira da Silva  
Paulo Roberto Sousa Rocha  
Simone da Fonseca Sanghi

#### Coordenação Pedagógica

Amirah Adnan Salman  
Andrea Cristina Lovato Ribeiro  
Bárbara Cury Soubhia  
Manuela Samir Maciel Salman

#### Coordenação de Pesquisa e Relatórios

Luiz Augusto Facchini  
Elaine Thumé  
Elaine Tomasi

#### Coordenação de Mídias e Comunicação

Samir Salman  
João Rocha Rodrigues  
Luana Copini Jahn

#### Coordenação de Tecnologia e Informação

Alessander Osório

#### Coordenação da Produção

Alexandre Moretto Ribeiro  
Andrea Cristina Lovato Ribeiro

#### Revisão Gramatical/Ortográfica e ABNT

Giulia M. Delazzeri

#### Produção Audiovisual

Eduardo Dias Abreu

#### Assistente de Produção Audiovisual

Luciana Melo

#### Animação

Márlon Lima

#### Ilustração

Mario Vitor Gouveia Cau

#### Diagramação e Design Gráfico

Daniele Rossi

#### Design Web e Programação

Vando Pinto

#### Conteúdo

Anamaria Siriani de Oliveira  
Antonio Seixlack  
Arthur Fernandes da Silva  
Bernardo Diniz Coutinho  
Débora Silva Teixeira  
Fabianna Resende de Jesus  
Moraleida  
Fernanda de Figueiredo Torres  
Fernanda Martins Pereira  
Hildebrandt  
Fernanda Pereira de Paula Freitas  
Francinete Araujo  
Josimari Melo de Santana  
Juliana Marques Coelho Bastos  
Marco Túlio Cária Guimarães Pereira  
Marcos Lisboa Neves  
Marcos Paulo Veloso Correia  
Mariana Cabral Schweitzer  
Milene Zanoni da Silva  
Rodrigo Macedo Pacheco  
Rui Ferreira Afonso  
Sandra Fortes

### CRÉDITOS DESTE RECURSO DIDÁTICO

#### Conteúdo

Anamaria Siriani de Oliveira



UFPEL

